

LE QUOTIDIEN EN EHPAD

Soins, repas, nuit, sorties, argent — ce qui se passe vraiment.

Guide E — Série pratique EHPAD · Culture du soin

Sommaire

1. Les soins au quotidien — ce qui se passe réellement

Toilettes, médicaments, plaies, chutes — comprendre sans imaginer le pire.

2. Les repas — un enjeu sous-estimé

Nutrition, goûts, textures, plaisir — ce que vous pouvez influencer.

3. La nuit — ce que vous ne voyez pas

Ce qui se passe entre 21h et 7h, et pourquoi c'est important.

4. Les sorties et les visites — votre présence organisée

Ce que vous pouvez faire, comment l'organiser, ce qui aide vraiment.

5. L'argent et les affaires personnelles

Argent de poche, vêtements, objets, ce qui appartient à qui.

6. Ce que vous pouvez apporter — et ce qui aide vraiment

Les gestes concrets qui font une vraie différence au quotidien.

Introduction

Le quotidien en EHPAD, c'est ce que vous ne voyez pas. Vous arrivez pour une visite, vous repartez. Entre les deux — il se passe des choses. Des soins, des repas, des nuits parfois agitées, des moments de calme, des tensions, des petits bonheurs.

Ce guide est là pour vous aider à comprendre ce quotidien — pas pour le surveiller, mais pour mieux l'accompagner. Parce que plus vous en comprenez le fonctionnement, plus vous pouvez y avoir une influence positive.

Ce que j'observe sur le terrain

Ce qui fait la différence dans le quotidien d'un résident, ce ne sont pas toujours les grands gestes. C'est souvent un détail : son parfum préféré mis sur son poignet le matin. Sa musique dans la chambre en fin d'après-midi. Un soignant qui sait qu'il a peur quand on éteint la lumière. Ces détails, c'est vous qui pouvez les apporter — l'équipe ne les connaît pas toujours.

1. Les soins au quotidien

La toilette et les soins d'hygiène

La toilette est réalisée chaque matin, généralement par une aide-soignante. Elle comprend le lavage, l'habillage, les soins de bouche, le rasage ou la coiffure. C'est un moment intime — et c'est aussi un moment d'observation : l'aide-soignante note les évolutions de l'état cutané, les douleurs, les réactions inhabituelles.

Ce que vous pouvez faire : Transmettre les préférences de votre proche — ordre de la toilette, produits utilisés, zones douloureuses, réactions à éviter. Ces informations font une vraie différence dans le confort ressenti.

Les médicaments

Les médicaments sont préparés et administrés par les infirmières, selon la prescription du médecin. En général trois passages par jour — matin, midi, soir. Les médicaments apportés de l'extérieur par la famille sont généralement interdits sans prescription — même les compléments alimentaires ou les médicaments en vente libre. Demandez toujours avant d'apporter quoi que ce soit.

Les plaies et escarres

Les personnes âgées à mobilité réduite sont particulièrement vulnérables aux escarres — plaies de pression qui se forment sur les points d'appui (coccyx, talons, omoplates). Les établissements doivent avoir des protocoles de prévention : changements de position réguliers, matelas adaptés, surveillance de la peau.

Si vous observez une plaie ou une rougeur : signalez-le immédiatement à l'infirmière. Ne tentez pas de la soigner vous-même. Demandez quel protocole est en place et quel suivi est prévu.

Les chutes

Les chutes sont fréquentes en EHPAD — et souvent inévitables totalement. L'établissement a l'obligation de vous prévenir dès qu'une chute se produit, même sans blessure apparente. Il doit aussi documenter chaque chute et mettre en place un plan de prévention individualisé.

Ce que vous pouvez demander après une chute : les circonstances, le bilan réalisé, et les mesures mises en place pour éviter une récurrence.

Les soins du quotidien sont invisibles pour vous. Mais ils sont le cœur de ce que vit votre proche chaque jour.

2. Les repas — un enjeu sous-estimé

Les repas structurent la journée. Ils sont aussi l'un des premiers indicateurs de l'état de santé — une perte d'appétit, une difficulté à avaler, un refus de manger sont des signaux importants. Et le repas est un moment de lien social — pas juste de nutrition.

La structure des repas

En général : petit-déjeuner vers 8h, déjeuner vers 12h, goûter vers 15h, dîner vers 18h30-19h. Les horaires peuvent sembler tôt — c'est une réalité des établissements liée aux contraintes de personnel. Si les horaires vous semblent inadaptés à votre proche, signalez-le à la cadre.

Les textures adaptées

Quand votre proche a des difficultés à mâcher ou avaler (dysphagie), les repas peuvent être adaptés : texture moulinée, mixée, ou en nectar/crème pour les liquides. Ces adaptations doivent être prescrites et figurer dans le dossier. Si votre proche s'étouffe régulièrement — c'est un signe à signaler immédiatement.

Ce que vous pouvez influencer

- Transmettre les goûts et aversions de votre proche — par écrit, à l'équipe et à l'animatrice.
- Apporter des produits alimentaires supplémentaires — chocolats, biscuits préférés, fruits — en vérifiant qu'ils sont compatibles avec son régime.
- Partager un repas avec lui — si l'établissement le permet, c'est un moment précieux.
- Alerter si vous observez qu'il mange très peu ou refuse de manger — c'est souvent le premier signe d'une dégradation.

Un repas qu'on aime, pris avec quelqu'un qu'on aime — c'est encore de la vie. Ne le sous-estimez pas.

3. La nuit — ce que vous ne voyez pas

La nuit en EHPAD est un angle mort pour les familles. Et pourtant, c'est souvent la nuit que les problèmes apparaissent — agitation, chutes, anxiété, douleurs. Comprendre comment fonctionne la nuit vous aide à poser les bonnes questions.

Le fonctionnement de nuit

La nuit, les effectifs sont réduits — souvent une infirmière et un ou deux aides-soignants pour l'ensemble de l'établissement. Les passages en chambre se font à heures fixes ou selon les besoins signalés. Les résidents peuvent appeler via une sonnette — vérifiez que votre proche sait l'utiliser et qu'elle fonctionne.

L'agitation nocturne

C'est fréquent chez les personnes atteintes de démence — le syndrome crépusculaire se prolonge parfois dans la nuit. L'établissement doit avoir des protocoles adaptés : présence rassurante, environnement sécurisé, limitation des médicaments sédatifs au profit d'approches non médicamenteuses.

Ce que vous pouvez demander : comment se passent les nuits de votre proche ? Est-ce qu'il dort ? Est-ce qu'il est agité ? Est-ce qu'il y a eu des incidents nocturnes ? Ces questions sont légitimes et utiles.

Les changes nocturnes

Pour les résidents incontinents, des changes sont réalisés pendant la nuit — en général une ou deux fois. C'est une source fréquente de réveil et de perturbation du sommeil. Si votre proche se plaint de mal dormir — demandez à la cadre d'évaluer l'organisation des changes nocturnes.

Une bonne nuit change tout à la journée. Posez des questions sur les nuits de votre proche.

4. Les sorties et les visites

Les sorties — ce qui est possible

Votre proche a le droit de sortir. Ce n'est pas une permission que l'établissement accorde — c'est un droit. Il faut simplement organiser logistiquement : prévenir l'équipe à l'avance, vérifier que la sortie est compatible avec son état de santé du jour, prévoir les médicaments si la sortie dépasse un repas.

Même une courte promenade dans le jardin, un déjeuner en famille à l'extérieur, une sortie de quelques heures — tout cela est possible et précieux. Ces sorties maintiennent le lien avec le monde, les habitudes, les plaisirs.

Comment organiser une sortie

- Prévenez l'équipe 24 à 48h à l'avance.
- Vérifiez l'état de votre proche le jour J — une mauvaise journée peut justifier d'annuler ou d'adapter.
- Demandez les médicaments à emporter si nécessaire — conditionnés et étiquetés par l'infirmière.
- Signalez votre retour à l'équipe à votre arrivée.

Vos visites — comment les rendre utiles

Il n'y a pas de fréquence idéale. Une visite courte et présente vaut mieux qu'une longue visite distrait. Voici ce qui fonctionne vraiment :

- Arriver à un moment où votre proche est dispos — pas en plein repas, pas à l'heure de sieste, pas en fin de journée s'il est souvent agité à ce moment.
- Apporter quelque chose de sensoriel — une odeur, une texture, une musique. Cela crée une présence même quand la conversation est difficile.
- Prévenir l'équipe si vous êtes souvent absent — ils peuvent vous appeler si quelque chose change.

Votre présence a une valeur que personne d'autre ne peut remplacer. Même courte. Même silencieuse.

5. L'argent et les affaires personnelles

L'argent de poche

Votre proche conserve le droit d'avoir de l'argent personnel. Une somme réduite peut être gardée en chambre pour les petits achats (journaux, confiseries, coiffeur de l'établissement). L'établissement peut gérer cet argent de poche — mais doit en tenir un registre transparent, accessible à la famille ou au tuteur.

Attention : ne laissez pas de grosses sommes en chambre. Les objets de valeur (bijoux, montre) doivent être déclarés à l'entrée. En cas de perte, la responsabilité de l'établissement peut être engagée — mais seulement pour les objets déclarés.

Les vêtements

Chaque vêtement doit être marqué au nom du résident avant d'entrer dans l'établissement. Le linge est entièrement à la charge de l'établissement — lavage, séchage — dans la plupart des EHPAD. Cela signifie aussi que les vêtements délicats peuvent abîmer plus vite. Prévoyez des vêtements pratiques, confortables, résistants au lavage industriel.

Si des vêtements disparaissent : signalez-le à l'aide-soignante, puis à la cadre. Cela arrive — souvent par erreur de tri. Un suivi écrit facilite la résolution.

Les objets personnels

La chambre est l'espace privé de votre proche. Il peut y avoir ses affaires, ses photos, ses objets fétiches. Ces objets ont une valeur affective considérable — ils maintiennent un lien avec son identité et son histoire. Personnalisez la chambre. Apportez des photos, un objet familial, quelque chose qui lui ressemble.

Sa chambre n'est pas juste un lit dans un couloir. C'est son territoire. Aidez-le à y exister.

6. Ce que vous pouvez apporter — et ce qui aide vraiment

Au-delà de votre présence, voici ce que les familles apportent qui fait une vraie différence — et ce qui, parfois, complique les choses.

Ce qui aide vraiment

- **Ses aliments préférés** — en vérifiant qu'ils sont compatibles avec son régime. Chocolat, biscuits, fruits — ces petits plaisirs comptent énormément.
- **De la musique** — ses chansons, ses artistes, son époque. Un petit haut-parleur Bluetooth avec une playlist préparée à l'avance peut transformer l'atmosphère de sa chambre.
- **Des photos récentes** — de vous, des enfants, des petits-enfants. Mises à la hauteur de ses yeux, là où il regarde souvent.
- **Son parfum ou sa crème habituelle** — une odeur connue active la mémoire émotionnelle même à un stade avancé.
- **Un objet familier à tenir** — pour les personnes agitées ou à mains actives, un tissu doux, un objet lisse à manipuler peut réduire l'anxiété.
- **Des nouvelles de la famille** — raconter ce qui se passe dehors, même simplement. Il reste vivant dans le monde à travers vous.

Ce qui peut compliquer les choses

- Des médicaments ou suppléments apportés sans en parler à l'équipe — risque d'interaction, de surdosage.
- Des aliments inadaptés à son régime ou à sa texture — risque de fausse route pour les personnes dysphagiques.
- Trop d'objets en chambre qui rendent la circulation difficile pour les soignants ou risquent des chutes.
- Des visites à des heures qui perturbent les soins ou le repos — demandez les plages les plus adaptées.

*Vous connaissez votre proche. L'équipe connaît son patient.
Ensemble, vous le connaissez entier.*

Le quotidien, c'est là que tout se joue.

Pas dans les grandes décisions. Dans les petits moments de chaque jour.

—

Ce guide fait partie de la série pratique EHPAD. Les autres guides de la série :

- **Guide A — Qui est qui :** rôles, responsabilités, bons interlocuteurs.
- **Guide B — Parler à l'équipe :** quand, comment, à qui, par écrit.
- **Guide C — Les réunions :** CVS, synthèses, projet de vie.
- **Guide D — Vos droits :** accès dossier, réclamation, loi.
- **Guide F — Quand ça coince :** conflits, signalement, recours.
- **Guide G — Le changement d'EHPAD :** quand et comment partir ailleurs.

—

Et si vous avez besoin d'aide pour comprendre une situation spécifique, préparer une visite difficile ou ne pas traverser ça seul — je suis là.

[Votre lien de contact / site]

— *Culture du soin*